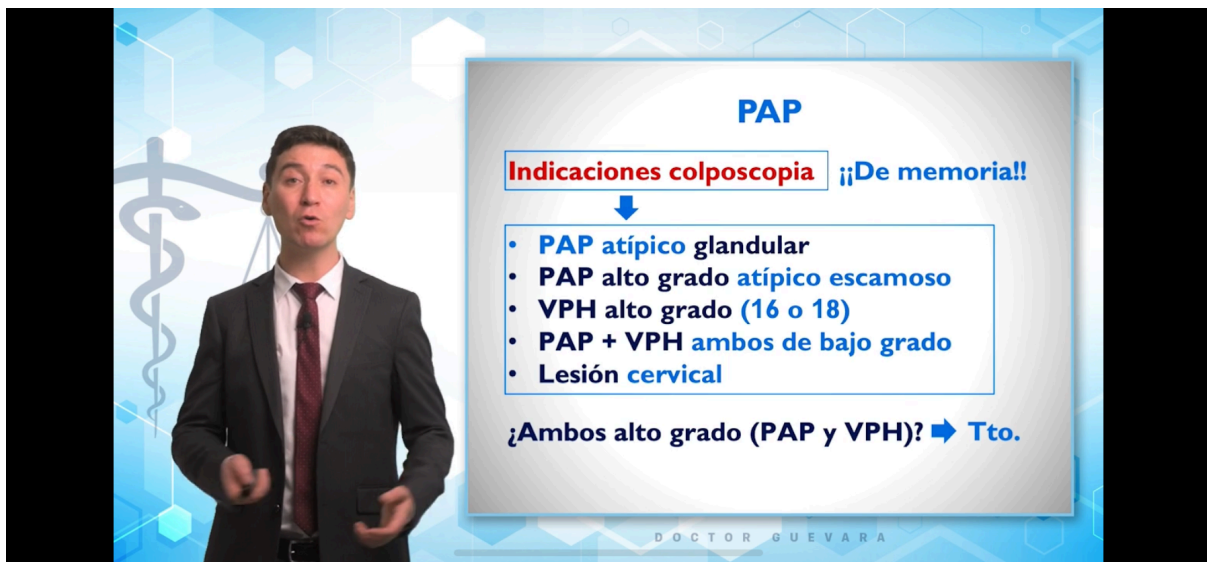


RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2024

1. Niño con aumento volumen de párpado, eritema, y secreción purulenta, no puede abrir el ojo:
 - a. **Celulitis periorbitaria (sin oftalmoplejia, dolor al mover el ojo, proptosis, disminución de la agudeza visual) Según yo salía que no podía abrir el ojo, decía literalmente “dolor al-1hh1-examen oftalmológico, eso se puede fasumir como dolor a la oculomotilidad)**
 - b. celulitis orbitaria
 - c. Chalazion infectado
2. Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.
 - a. **Lupus cutáneo crónico**
 - b. Dermatitis seborreica
 - c. Psoriasis
 - d. Liquen plano
 - e. Rosácea
3. Vacuna embarazada para prevenir enfermedad de hijo en los primeros meses de nacimiento:
 - a. **influenza**
 - b. Varicela
 - c. Tres virica
 - d. Fiebre amarilla
 - e. Meningococo conjugada
4. Clínica de Sarna (perlada) con acarotest negativo manejo:
 - a. **Permetrina**
 - b. Ivermectina
 - c. Repetir acarotest
 - d. Vaselina azufrada
5. Niño adenopatía, fiebre, lesiones focales esplénicas
 - a. **Estudio bartonella henselae**
6. Veterinario expuesto a ganado, dolor articular. Artrocentesis con PMN 70%
 - a. **brucelosis**
 - b. **Fiebre Q**
 - c. Cultivo de gonococo
 - d. Hemocultivo
7. IMAGEN: Persona en situación de calle con hemitórax radiopaco:
 - a. **Derrame pleural masivo**
8. Guagua de 2 meses con ITU x atipico (nitritos (-)), fiebre, irritabilidad, con 60 blancos, bacterias abundantes:
 - a. **Hospitalizar + ATB amplio espectro. (ITU < 2 meses, ITU Atípica)**
 - b. **ATB vo y control con UC (la guagua estaba regio, sgy igual podía ser esa), no, menor a 3 es indicación absoluta de hospitalizar (mmm, pero estaba febril, así que la sospecha era PNA) Y estaba “decaído”**
9. Postmenopáusica con antecedente de IAM y bochornos:
 - a. **iniciar Escitalopram**

- b. Resto opciones tenían estradiol
10. Anticoncepción en mujer con HTA reciente diagnóstico IMC 34 que tomaba ACO combinado hace 10 años:
- Estrógenos vo
 - Estrógenos intradérmicos
 - Progestágenos vo**
 - Reducir dosis estrógenos
 - Anillo vaginal SIII YO PUSE ESO**
11. PAP lesión de alto riesgo + VPH (+) 16 y 18: conducta
- Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono)**
 - Cono:** según Guevara lesión de alto grado + VPH de alto grado es indicación de tratamiento al tiro (noo, LIE o VPH de alto grado son indicaciones por si solas de colpo + bx pero juntas no cambian la conducta, las únicas indicaciones de cono son NIE II, NIE III, Ca in situ y disociación colpocitológica)



12. Disociación colpocitológica (PAP NIE III y colpo normal):
- Cono**
 - Volver a hacer legrado endocervical
 - Repetir en 6 meses
13. Niña 3 años con fisura anal resuelta, continua con constipación cual es el manejo adecuado:
- Lactulosa
 - PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua (manejo conductual) que también estaba como alternativa, así q yo asumí q no era esa**
 - colonoscopia
 - Agua 2L
 - Aumentar consumo de fibra**
14. Paciente 50 años aprox con cambio de hábito intestinal y baja de peso 8 kilos:
- colonoscopia**

15. Niña de 8 años consulta por talla baja, tiene percentil de crecimiento 4, con velocidad de crecimiento normal, y edad ósea de 7 años 10 meses, madre mide 1.52 y padre 1.65: cual es la conducta a seguir
- Controlar en 6 meses**
 - Pedir GH
 - Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)
16. Niño de 13 años con ginecomastia unilateral y masa 3 cm retroareolar, genitales tanner 3: (repetida años anteriores)
- Observar 1 año**
 - Eco mamaria
17. Glucosuria en embarazo de 24 semanas con HGT normal es indicativo de
- Normal**
 - Hallazgo precoz de preeclampsia
 - Hallazgo precoz de daño renal crónico
 - Hallazgo de alteración de tubo proximal (no recuerdo muy bien)
18. Sd compresión medular en paciente con Ca de próstata y Mtt ósea. Estudio:
- Rnm columna con gadolinio**
 - Mielografía
 - Cintigrama óseo
 - Radiografía columna
 - TAC
19. Mujer con síntomas menopáusicos, con FRCV, histerectomizada, cuál es la mejor opción de manejo:
- Estradiol tópico**
 - Estradiol
20. Hipertiroidismo con nódulo tiroideo sólido en ecografía, de 2.5 cm + TSH 0.7. Con qué examen continuar estudio:
- Cintigrama tiroideo**
 - PAAF
21. Lactante 2 meses, cuadro de 7 días de fiebre, adenopatías, inyección conjuntival.
- Kawasaki**
22. Hombre con antecedente de cirugía bariátrica hace 1 año+consumo de OH desde hace 7 meses, deja de asistir a control médico, parte con 1 semana de evolución de ataxia, dificultad de la marcha, visión doble, confusión, somnolencia, cual es la deficiencia:
- Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda.** Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).
 - Vitamina B12
 - Vitamina C
23. Mujer en trabajo de parto, feto en cefálica, Bishop 8, dilatación 10 cm, encajado, presentación de cara, Mentón- posterior cual es la conducta
- Cesárea**
 - Forceps
 - Vacum
 - Continuar tdp (la presentación de cara no tiene contraindicación de cesárea, la de frente si) eso!!! (Pero ojo la variedad de posición mento púbica = mentón-anterior, es la única NO distócica según Guevara, por**

lo que la Mentón posterior de este caso debería ser indicación de cesárea)... Había una opción que decía reevaluar en 2 horas

- e. Realizar prueba de trabajo de parto
- 24. Embarazo a término, 39 semanas con PBF 6/8 con LA 0/2 conducta
 - a. Inducir
 - b. **Cesárea**
 - c. **Eco doppler seriado Según entiendo, era un OHA idiopático, lo que no es malo, pero hay que hacerle eco doppler para ver si hay insuficiencia placentaria, era muy similar a una de un ensayo.. si pero como estaba de termino mejor la interrumpes..., se suelen interrumpir a las 40, tenia 37**
- 25. IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:
 - a. Mebendazol
 - b. Albendazol
 - c. **Praziquantel**
 - d. Ivermectina
- 26. RN de término convulsión a las 12 hrs de 2 minutos de duración. A la evaluación todo normal hgtes: diagnóstico más probable
 - a. Epilepsia
 - b. **Hipoglicemia**
 - c. **Hipocalcemia**
 - d. Hemorragia intracerebral
- 27. Alteración metabólica que se debe buscar en PEG
 - a. Hiperglucemia
 - b. hipercalcemia
 - c. **Anemia**
 - d. **Poliglobulia (la poliglobulia no era más de GEG?)**
 - e. Trombocitosis
- 28. Niño que juega en huerto que evoluciona con sialorrea y miosis
 - a. **Intoxicación por organofosforado**
- 29. Lactante con FC 280 lpm regular, soporoso, pulsos femorales disminuidos, no se puede medir PA. ¿Cual es la conducta?:
 - a. **Cardioversión**
 - b. Adenosina
 - c. Maniobras vasovagales (PORQUE NO PUEDE SER ESTA DE MANERA INICIAL???) - pulsos disminuidos se puede interpretar como compromiso HDN... ademas maniobras vagales requieren que el pcte coopere y tenia como 2 años
- 30. ITU febril en guagua. ATB con resistencia pero sensible a nitrofurantoína. Cual le dejass (entregaban antibiograma, era E.Coli blee positivo):
 - a. **Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos)**
 - b. **Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente**
 - c. **Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible**
- 31. Mujer con síntomas ansiosos y EKG (taquicardia regular QRS estrecho aprox 150 lpm):
 - a. **Adenosina**

32. Mujer con síntomas depresivos, hipersomnia, aumento de peso (relataba un cuadro clásico de depresión atípica):
- Sertralina**
 - Mirtazapina
- *No salían IMAO en las alternativas
33. Hombre politrauma se hace TAC hematoma epidural + neumotórax con desviación de tráquea + derrame pericardico extenso, que vuelve del TAC con deterioro hemodinamico. Conducta inicial:
- Pleurostomía**
 - Reanimación
 - Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía
34. Mujer con fractura de pelvis inestable con shock: conducta de reanimación inicial:
- SF 0,9%** yo puse esto u.u
 - Cerrar anillo pélvico (pienso que es esta porque es lo único que disminuirá el sangrado que le está matando)** Pero preguntaban por manejo del shock inicial
 - Tratamientos específicos de la causa
 - Reparación arterial
35. Paciente femenina con antecedente de episodio depresivo mayor hace 5 años tratada, nuevamente sintomática, parte antidepresivos y evoluciona con cambios de conducta aumento de energía:
- Bipolar**
36. Paciente masculino con consumo OH crónico, pierde su trabajo, se fractura tobillo y se hospitaliza, pide alta voluntaria para ir a tomar cerveza, qué conducta define mejor la “adicción” x OH:
- La conducta durante la hospitalización**
 - Pérdida de trabajo
 - Embriaguez
 - La frecuencia del consumo
37. Hombre piensa que puede ser pedofilo, le perturba el pensamiento recurrente así q cuando lo piensa repite una frase: (repetida años anteriores)
- TOC**
38. Ca cu con sangrado activo q no responde a ac tranexámico:
- Taponamiento vaginal (REPETIDA DE AÑO ANTERIOR)**
 - Ligar arterias cervicales
39. Hombre con ascitis a tensión y fiebre y encefalopatía:
- Estudio liquido**
40. Paciente en tratamiento anti hipertensivo + sd vertiginoso en tto con Cinarizina, metformina, inicia temblor de reposo, simétrico, bilateral, rigidez y asociado a caídas frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- Parkinson **POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico**
 - Parkinsonismo por fármacos**
41. Hombre 60 años con inicio hace 3 semanas de carbamazepina, comienza con náuseas, malestar gástrico, confusión hace 2 días, alteración electrolítica:
- Hiponatremia**

- b. **HIPOCALCEMIA???**. Era hiponatremia inducida por carbamazepina. - además la clínica (compromiso SNC) orientaba a disnatremia, no tenía nada de discalcemia/diskalemia.
 - c. Hipokalemia
42. Paciente con cefalea importante que convulsiona y tiene compromiso de conciencia? (soporoso?), con LCR MN y GR:
- a. **Encefalitis por VHS**
 - b. MAB
 - c. Meningitis viral
43. Síndrome adrenérgico por cocaína. Fármaco contraindicado.
- a. **Atenolol**
 - b. Captopril
 - c. Nitroglicerina
 - d. Diltiazem
44. Nódulo hepático sólido: Estudio con ecografía abdominal > con que continuar el estudio
- a. **TAC Trifásico**
 - b. Biopsia
 - c. RNM
 - d. Eco
45. Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?:
- a. **Azitromicina**
 - b. Hidratación + probióticos (según yo porque campylobacter solo se trata con ATB en casos severos.)
 - c. Ciprofloxacino
46. Mujer con dolor en metacarpofalángicas, IFP y rodillas, con dolor matutino mayor a 1 hora ¿Cuál es el diagnóstico?
- a. **Artritis Reumatoide**
47. Tratamiento ATB de una osteomielitis de cadera en niño de 10 años:
- a. Cefazolina **Cefa pq no tenía factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco)**
 - b. **Vancomicina**
 - c. Ampicilina
48. Luxación anterior de hombro reducida + hipoestesia en cara lateral de brazo, nervio comprometido
- a. Mediano
 - b. Cubital
 - c. Radial
 - d. **Axilar**
 - e. Musculocutáneo
49. Se hace estudio de FRCV y alimentación en estudiantes medicina en el año 2000. En el 2022 se reevalúa a los mismos para ver aparición de enfermedades cv. Qué tipo de estudio es:
- a. **Cohortes prospectivo.**
 - b. Cohorte retrospectivo
 - c. Caso control

- d. Transversal
- 50. Disfagia a nivel de xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso de agua. Conducta:
 - a. **EDA**
 - b. Radiografía
 - c. Nasolaringoscopia
 - d. Manometría esofágica
- 51. Mueren 7 niños menores de 1 año por cada 1000 RNV. Cómo se llama el parámetro:
 - a. **Tasa de mortalidad infantil**
 - b. Tasa de mortalidad Neonatal
 - c. Mortalidad neonatal tardía
 - d. Mortalidad
 - e. Letalidad
- 52. Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:
 - a. Avisar al delegado de epidemiología
 - b. **Notificar inmediatamente a la SEREMI**
 - c. Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
- 53. Institución encargada de que lo medico legal cumpla con la seguridad social algo asi
 - a. **Compin**
 - b. SIS
 - c. SUSESO
 - d. Medicina legal
- 54. Mujer que comienza con hipoacusia y tinnitus. ¿Cual es el examen inicial? (Repetida años anteriores)
 - a. Impedanciometría
 - b. **Audiometría,**
- 55. Funciones de la SIS
- 56. Embarazada de 32 semanas con sx de cole. Eco pared engrosada con calculos y VB 9 o 10 cm. Conducta:
 - a. **Analgesia hasta fin del embarazo**
 - b. CPRE (PORQ ESTA NO PODRIA SER???) - SGY Porque no tenía clínica de colangitis, que sería la indicación de drenaje inmediato. Sino sólo sospecha de coledocolitiasis.
 - c. colecistectomía+CIO
 - d. colecistostomía
 - e. **Colangioresonancia**
- 57. Dolor de rodilla jugando fútbol por movimiento de torsión, al examen físico con dolor al valgo, sin bostezo:
 - a. Rotura ligamento cruzado posterior
 - b. Ligamento cruzado anterior
 - c. **Esguince colateral medial (pero no tenía bostezo)**
 - d. Rotura menisco medial (tenía sentido con el mecanismo de lesión en torsión)
- 58. Disminución de los movimientos fetales de 12 horas de evolución con LCF (+) conducta:
 - a. **RBNE**
 - b. Test de tolerancia a las contracciones

59. Hipertensión renovascular (yo vi 2 hiperaldosteronismos primarios, confirmo x2) habían 2, uno joven con muchos síntomas de hipokalemia (HAP) y la otra era adulto mayor con proteinuria (HTRV)?
vs Hiperaldosteronismo primario
60. Ca normal PTH elevada vitamina D baja P bajo, calcio urinario bajo + anemia Ferritina 5.
- a. Hiperparatiroidismo primario
 - b. Hiperparatiroidismo Terciario
 - c. **Enfermedad celiaca(ojo tenía ferritina en 5, lo que orientaba a enf. celiaca)**
 - d. Osteoporosis
61. Mujer de no se q edad 40-50? Menopáusica con clínica de 5 años de evolución con dispareunia y sequedad vaginal severa, sin ningún otro síntoma. con antecedente de ca de mama en tto con tamoxifeno. preguntan conducta inicial
- a. **Lubricante e hidratante vaginal**
 - b. Estrógenos vaginales
 - c. Suspender tamoxifeno
62. Síncope en un adulto mayor que iba caminando, pierde conciencia subitamente, se golpea la cabeza y queda con herida en cuero cabelludo, se recupera bien, FC 60. El estudio inicial del cuadro (ojo no decía etiológico):
- a. **Estudio inicial con ecg (sería esta si preguntaran la causa)**
 - b. **TAC cerebral (sería esta si preguntan por el estudio del TEC -por ser adulto mayor se debe estudiar-)**
63. Viejito q consulta x miedo a caídas, caída hace 10 meses sin lesiones actualmente. Se constata atrofia leve de cuádriceps. Test tiempo en pararse y caminar en 14 (VN: <14 seg) test de cuanto dura parado en 1 pie de 3 seg. Conducta:
- a. **Ejercicios multicomponente**
 - b. **Fortalecimiento cuádriceps**
 - c. **Caminata diaria**
 - d. Bastón (Yo puse bastón pq por GES ya puede optar a ayudas técnicas y así previene que se caiga, fracture y pueda realizar ejercicios, aunque según yo lo primordial es el ejercicio xd)
 - e. Ejercicio aeróbico
64. Persona hospitalizada operada hace unos días clínica sugiere:
- a. **Delirium**
65. IMAGEN: Lactante con dermatitis del pañal (foto), con tratamiento previo con óxido de zinc, cual es el tratamiento:
- a. **Clotrimazol tópico (cándida clotrimazol tópico, según yo era esta porque se veían lesiones satélite)**
 - b. **betametasona.**
 - c. **Hidrocortisona topica**
66. Paciente con clínica telangiectasia, esclerodermia, síndrome de raynaud e hipertensión pulmonar, examen de elección para confirmar **etiología** diagnóstico:
- a. **Ecocardiograma TE (porque no puede ser esta?) (Era un CREST y estaba así por hipertensión Pulmonar, se dg oficialmente con Cateterismo- además ya te describían el ecocardiograma en la pregunta)**
 - b. **Cateterismo cardiaco derecho**

- c. Cintigrama pulmonar, esta hace el dx de Fibrosis pulmonar.
 - d. Radiografía tórax
 - e. AgioTC de tórax
67. Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático
- a. **benzodiazepinas**
 - b. ISRS
 - c. Triciclicos
 - d. Antipsicoticos tipicos
 - e. **Antipsicóticos atípicos**
68. Sd de down q se cansaba al mamar con soplo continuo con pulso saltón:
- a. **DAP**
 - b. **Canal AV** - cuál era esta??? DAP porque el soplo era continuo, sin embargo, canal AV es la primera valvulopatía en sd down y se preguntó en pruebas anteriores :(
 - c. Comunicación Inter ventricular
69. Mujer 70 años con orina de mal olor, sin ningún síntoma urinario, sedimento leucocitos 2-3/campo, bacterias abundantes . Conducta:
- a. **Se observa y controla si parte con síntomas**
70. Mujer con hipoacusia neuro con ITU febril → PNA . Qué ATB dejar:
- a. **Meropenem**
 - b. Gentamicina
 - c. Amikacina
 - d. Nitrofurantoína → **aminoglucosidos estarían contraindicados en hipoacusia neurosensorial o no?? si pq son ototoxicos**
71. Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias:
- a. **Desprendimiento de retina**
72. Lactante de 18 meses, irritable , con sedimento y urocultivo (+), fiebre y decaimiento hace 3 días, antibiograma sensible a imipenem, cipro, Amikacina. ¿qué tratamiento indicar?
- a. **Amikacina**
 - b. **Carbapenemicos**
73. Paciente púerpera con mama eritematosa con calor local y aumento de volumen fluctuante de 7 cm, además de iniciar atb, se debe;
- a. **Drenaje de absceso mamario,**
 - b. Suspende LM
74. Tratamiento de elección para paciente afebril y en BCG, con forúnculo con cultivo de secreción: S. Aureus Resistente a: Clinda / Cefa; Sensible a Linezolid / Vanco
- a. **Drenaje**
 - b. Hospitalizar y Vancomicina ev
 - c. Linezolid vo
75. El uso del enmascaramiento (doble ciego controlado) como medida en estudios epidemiológicos tiene como objetivo:
- a. Disminuir el sesgo de **información**
 - b. Disminuir **sesgo de selección** (es de información, en específico los subtipos del evaluador y el evaluado, sesgo de selección sería realizar un estudio excluyendo de la muestra de estudio una población específica y relevante)

- c. Darle mayor valor al estudio
 - d. Disminuir el error aleatorio
76. Mamografía BIRADS 0, se realiza ECO y resulta BIRADS 2, conducta:
- a. **Control 6 meses con eco (no describían la lesión pero asumo que se trataba de un fibroadenoma mamario y esta sería la conducta)**
 - b. Control 6 meses con mamografía (BIRADS 2 se controlan en 1 año con mamografía así que esta no podía ser)
77. Absceso interglúteo 2 cm, paciente BEG, cual es la conducta:
- a. ATB
 - b. **Drenar**
 - c. Marsupialización
78. Paciente HTA en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, metas fuera de rango con proteinuria que hipotensor es el indicado:
- a. **Enalapril.**
79. Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:
- a. **Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)**
80. Hombre con poliuria, polidipsia y nicturia. Toma 8 lts de agua al día. En los exámenes destaca hiponatremia, como inicia el estudio?
- a. Ecografía renal
 - b. **Electrolitos urinarios** (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores
 - c. TAC de no se q
 - d. **Test de deprivación de agua (esto es para hipernatremia sg yo)**
 - e. Derivar a psiquiatría
 - f. PTGO
81. Paciente joven con diarrea de larga data, sin mucosidad ni sangre, TAC con engrosamiento íleon distal, diagnóstico, *calprotectina fecal elevada (1500 creo): **cáncer/Crohn/CU?** (Es Crohn) Tenia mas pinta de cancer<— no porque tenia 20 y tantos. Tenia 48 era viejo. Pero por el nivel de calprotectina y el compromiso de intestino delgado es Crohn...
82. Paciente que decía que le “temblaba el cuerpo” y en ocasiones se quedaba paralizada porque se subía al auto “no quería ir al trabajo y músculos no le respondían” y que fue estudiada por varios médicos (neurólogos e internistas) sin hallazgos y ya está cansada y quiere que la dejen morir, su familia o amigos están preocupados porque siempre ha sido una trabajadora ejemplar:
- a. **Conversivo**
 - b. **Hipocondria**
 - c. Depresión.(Según yo era una depresión psicótica)
 - d. Facticio (yo puse hipocondria jajfd), es que la hipocondria es la ansiedad por enfermedad, yo puse conversivo porque cuando dice que le tiembla el cuerpo igual describe una “convulsión”, por lo tanto conversivo es mas acorde. yo también puse conversivo porque eran síntomas neurológicos y se había hecho muchos estudios. No era conversivo porque los conversivos tienen “bella indiferencia” (lo cual no tenía) y suceden posterior a eventos traumáticos agudos (tampoco presente).

83. Paciente con trauma en región lumbar + hematuria, examen de elección:
- urotac**
 - Eco renal y pélvica
84. Alérgico a mariscos crudos con 2 reacciones anafilácticas previas en los últimos 3 meses, que indicarle a la mama:
- adrenalina SOS**
 - Corticoides VO en siguiente episodio
 - Antihistamínicos de uso permanente
 - Observar y consultar si le pasa algo al comer
 - Comer mariscos cocidos
85. Una joven que consulta por diarrea de meses, exige que la hospitalicen para estudio. Estudio normal. La pillan tomando laxantes, ella lo niega, no se sabe motivo por el que hace esto. ¿Cual es el diagnóstico?
- Trastorno facticio**
86. Lactante con estridor desde nacimiento causa
- Laringomalacia**
87. Huevo anembrionado aborto, si se le da licencia remunerada o no al papá(? Y cuantos días:
- Reposo por 10 días continuos remunerado (ley Dominga permite 10 días hábiles continuos!!)**
 - Permiso 7 días hábiles remunerado**
 - No tiene permiso porque no se demuestra embrión
 - Permiso de 5 días solo si hay unión civil (no recuerdo exactamente)
88. (88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:
- SCA
 - Dissección aórtica
 - NAC
 - IC aguda**
 - TEP
 - Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico. (SEGÚN YO ESTA NO ERA LA 88, YO ANOTÉ EXACTA LA 88). Dissección aórtica, SAO. NO esta en orden la reconstruccion porsicasooo agrega esa info en donde corresponde**
89. Mujer embarazada EG 10 semanas, con antecedente de PP con resultado de mortinato a las 26 semanas, con cervicometría actual de 20 mm. Conducta:
- Cerclaje de inmediato (creo que es esta porque tenía PP + CU <25 mm que es indicación de cerclaje profiláctico y esto era lo más cercano en las alternativas)**
 - Progesterona vaginal**
90. Mujer de 40 y tantos con aborto y a la especuloscopia se ve salida de vesículas:
- Enfermedad trofoblastica**
91. Paciente con 3 cálculos pequeños, 1 en unión vesicoureteral de 6 mm, los otros eran de 5 y 3 mm. Tenía unos en pelvis renal igual o no??: (según yo todos median mas de 10mm y si habían dos en la pelvis renal)
- Tamsulosina**

- b. **Nefrolitotomía**
 - c. **LEC**
 - d. Estudio metabólico
92. Lactante que llega sin test de audición a primer control:
- a. **Emisiones otoacústicas**
 - b. Impedanciometría
 - c. Evaluación por fono
 - d. Audiometría
 - e. Reflejo cocleopalpebral
93. DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta:
- a. **Mejorar calzado**
 - b. **Electromiografía**, realizar test de nuevo en unos meses (esta era RX para descartar osteomielitis)
94. Enfermera luego de su turnos de urgencia le cuesta dormir y se automedica con diazepam, conducta:
- a. Clotiazepam antes de dormir
 - b. Quetiapina
 - c. **Higiene del sueño/ control ambiental**
 - d. Zolpidem
95. ¿Como es la suplementación con ácido fólico en embarazo según la guía perinatal?:
- a. **3 meses preconcepcional hasta las 12 semanas de edad gestacional**
96. DPPNI (útero tónico, sangrado escaso) 32 sem aprox, se evidencia en eco leve desprendimiento de placenta.Cuál es la conducta:
- a. **Cesarea**
 - b. Interrumpir 34 sem
 - c. **Dar corticoides e interrumpir en 48 hrs**, era un DPPNI leve, sin sufrimiento fetal, no creo que sea cesárea de urg más considerando que tiene <34
97. Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:
- a. **cesarea inmediata**
 - b. **programar cesarea 39 semanas**
 - c. **esperar inicio tdp**
98. Mujer con reglas irregulares, test de embarazo +, fur no confiable pero si segura, amenorrea de 10 semanas. Como saber edad gestacional:
- a. **longitud cefalo- caudal**
 - b. longitud saco gestacional
 - c. niveles bcg
 - d. FUR segura
99. Emb de 32 semanas con Vih (+) sin tto, cual es la mejor conducta para prevenir transmisión vertical:
- a. **Iniciar TARV**
 - b. interrumpir embarazo
 - c. TARV intraparto
100. Cabro chico dm 1 con CAD, PA 90/60, FC 80, conducta inicial:
- a. **bolo 20mg kg en 30 min**

- b. **bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado)**
 - c. Insulina
- 101. Cetoacidosis cetonas (+) pH 7.1 K 3 conducta inicial **hidratar SF**
- 102. Mujer obesa 2-3 copas de vino sólo el fin de semana en tratamiento con estatinas, transaminasas con doble del valor normal:
 - a. **esteatohepatitis no alcohólica**
 - b. esteatohepatitis alcohólica
 - c. hepatitis por fármacos
 - d. hepatitis por VHC
 - e. Hepatitis AI
- 103. Px trasplante renal hace 9 años, usuario de tacrolimus, hace una semana de compromiso del estado general, dolor en zona injerto. Exs de rutina hace 10 días muestran niveles plasmáticos de tacrolimus >5 (estaba en rango normal), crea en 0.9. Exs actuales: crea 2.3, orina completa leucocitos y bacterias. ¿Diagnóstico? Alternativas:
 - a. Rechazo agudo
 - b. rechazo crónico
 - c. intoxicación por tacrolimus
 - d. **pielonefritis del injerto**
 - e. pielonefritis
- 104. Que se da solo después de los 12 meses
 - a. **miel**
 - b. huevo
 - c. pescado
 - d. carne de cerdo
 - e. carne de vacuno
- 105. Paro, en una reanimación, en condiciones idóneas como verifico que una IOT está bien hecha
 - a. **Capnografía**
 - b. Auscultación pulmonar
 - c. Saturación de O₂
 - d. Expansión torácica
- 106. Asmática con crisis tratada con corticoides VO por 5 días, al 5to día se le solicita seguimiento con exámenes, presenta glicemia 130.Cuál es la conducta más apropiada
 - a. Repetir glicemia en 1 semana
 - b. **Pedir hemoglobina glicosilada**
 - c. Solicitar PTGO
- 107. Paciente adulto mayor que no lograba erección, libido se conservaba, temor a que su pareja lo deje ya que antes tenían encuentros 1-2 por semana. Conducta:
 - a. **Sildenafil**
 - b. **Búsqueda de causa 2ria: tenía libido conservada, no describe ansiedad ante su performance, me parece relevante descartar causas secundarias (p ej diabetes) antes de asumir q su problema es psicológico**
 - c. **Terapia psicológica (justifiquen cada una)**

108. Embarazada 24 semanas con glicemia post 75gr de glucosa en 200 ¿Cual es el manejo?
- Iniciar insulina**
 - Metformina
 - Glibenclamida
109. IC en tratamiento con carvedilol e hidroclorotiazida, con HTA de reciente dg, Na normal, K en 4.0 , que fármaco se debe agregar:
- Diltiazem
 - Losartán**
 - BB
110. Paciente 27 años con espondilopatía o era sacroileítis?’, cual es el tratamiento inicial:
- Ibuprofeno**
 - Prednisona
 - Paracetamol (porque no puede paracetamol??)
111. IMAGEN: Calvo con antecedente de queratosis actínica, muestran lesión en cabeza:
- Carcinoma espinocelular**
112. Paciente adulta mayor con cuadro clásico de incontinencia urinaria de esfuerzo, conducta:
- Kinesioterapia pélvica**
113. Paciente con prurito, aumento grosor uñas en manos y pies, aumento volumen inguinal bilateral, foto de unas manos eritematosas, descamando:
- Linfoma cutáneo** (sd sezary)
 - Sarna noruega
 - Psoriasis
 - Dermatitis crónica
114. Paciente con glaucoma crónico, con ojo izquierdo con visión en túnel y ojo derecho con el signo de humo de chimenea, al evaluar el ojo con glaucoma crónico, ¿qué hallazgo tendría?:
- Midriasis arreflectica**
 - Reflejo ?/**
 - Miosis
 - Defecto pupilar aferente (esta porque la principal complicación del glaucoma crónico es el daño del nervio óptico que se vería con un DPA)**
115. Paciente con clínica y rayo de TBC, ¿Cual es el primer estudio que se debe realizar?
- Iniciar tratamiento
 - PCR (PCR porque es más sensible que BK y es lo que recomienda la nueva norma de TBC)**
 - Baciloscopias**
- por que PCR si era caso sospechoso? si hubiera sido contacto de alguien con TBC, se trata de entrada, pero el solo tenia clínica y rayo, lo que abre la sospecha, y la sospecha se confirma con PCR
116. Cómo medir la efectividad de una campaña de vacunación contra sarampión:
- prevalencia

- b. **Casos sospechosos nuevos notificados (mi duda con esta es que decía sospechosos, la idea de una vacuna es disminuir la incidencia de los casos confirmados,**
 - c. Seguimiento de los vacunados
 - d. **Estudio de casos de la eficacia**
 - e. Serología Ac de los casos sospechosos
117. Mujer 43 años con sangrado intermenstrual sin dolor, activa sexualmente con preservativo, cómo continuar el estudio:
- a. **BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)**
 - b. TSH y T4
 - c. FSH y LH
 - d. **Biopsia**

Yo puse biopsia **QUE PUSIERON?**, no convencía BHCG. Sg yo la beta era solo porque estaba en edad fértil pero igual hay que hacerle una eco si o si.

118. Adolescente con antecedente de trauma nasal hace 5-7 días, que consulta por fiebre y obstrucción nasal bilateral:
- a. Hematoma septal
 - b. **Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))**
119. Niño que consulta por sangrado post extracción dental (creo que tenía otros sangrados mucosos) con TTPA aumentado, plq normales, madre tenía reglas abundantes:
- a. **Enfermedad de Von Willebrand (se había preguntado el mismo caso en otro Eunacom y esta era la respuesta)**
 - b. Hemofilia
 - c. **Déficit de Vitamina K**

Era hemofilia ??? - es una **EVW EVW aumenta el ttpa si severa**

120. RNPT que a los 6 días inicia con vómitos importantes y deposiciones con sangre, abdomen timpánico con RHA disminuidos o ausentes (no recuerdo cual), que se vería en la radiografía:
- a. **Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)**
 - b. **Aire libre intraperitoneal**
 - c. Pared intestinal engrosada
 - d. Signo de doble burbuja
121. Adulto con PTI sin sangrado grave, plaquetas en 5.000:
- a. **Corticoides 1mg/kg**
 - b. Transfusión de plaquetas
 - c. Terapia biológica
122. Qué leche le das a un RN prematuro que ya tiene 12 meses:
- a. **Fórmula 3 de continuación** (se da fórmula prematuros hasta el año de edad corregida)
 - b. Leche de vaca
 - c. **Fórmula para prematuros**
 - d. Leche semidescremada
123. Eco Ginecológica con líquido libre conducta e inestabilidad HD
- a. **Cirugía de urgencia**

124. Pcte de 39 años con metrorragia e hipermenorrea, eco con endometrio homogéneo y masa en fondo uterino, conducta:
- histeroscopia** (según yo también x4, obs pólipo endometrial)
 - biopsia endometrial
125. Lactante con bronquitis a repetición, esteatorrea y anemia ferropénica:
- Fibrosis Quística**
 - Enfermedad celiaca
 - Inmunodeficiencia primaria
126. Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado:
- Diarrea por clostridium (según yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB)**
 - Reagudización de diverticulitis por rectitis**
 - Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU**
127. Paciente EPOC TBQ activo, con disnea, se va a hacer un EMPA y la enfermera le hace consejería para que deje de fumar para que mejore la disnea ¿Que tipo de prevención es?
- Prevención 1°
 - Prevención 2°
 - Prevención 3°**
 - Promoción de la salud (esta Era prevención terciaria) según yo era promoción porque igual depende del caballero si deja de fumar o no entonces no es un acto preventivo per se - Eso mismo**
 - Prevención 4
- Pero da la razón de consejería, es para mejorar disnea de enfermedad que ya tiene. Era prevención terciaria porque el paciente ya estaba sintomático, en fase de rehab.**
128. Niño con antecedente de resfriado de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:
- Amoxicilina**
 - Amoxicilina/ Ac. clavulánico
 - Ciprofloxacino tópico
129. Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuáles son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:
- Analítico
 - Ecológico
 - Descriptivo**
130. Paciente con antecedente de dolor en espalda, irradiado a glúteos, contractura paravertebral. **dolor a la palpación de la columna lumbar** y claudicación de la marcha y al estar mucho tiempo de pie, Lasegue negativo, rx de columna lumbar con pinzamiento discal y artrosis lumbar de L3-L4-L5 cuál era:
- Claudicación neural intermitente**
 - Fractura por compresión**
 - Pelvispondilopatía
 - Hernia lumbar

- e. Sacroileítis
- 131. Valvulopatía en paciente joven con síncope
 - a. **Estenosis aórtica**
- 132. IMAGEN: Paciente 66 años con neumonía (clínica e imagen de neumonía monolobar) saturando 94% ¿Cual es el tratamiento?:
 - a. Ceftriaxona
 - b. **Amoxicilina con Ac. clavulánico**
- 133. Caída en paracaídas, se observa deformidad en valgo:
 - a. **Fractura platillo tibial lateral (esta, confirmado por un TMT)**
 - b. Fractura cóndilo medial fémur
 - c. Rotura menisco anterior
 - d. Ligamento cruzado anterior
- 134. Paciente joven hiperventilando saturando 75%
 - a. **Venturi al 40 %**
 - b. Venturi al 24%
 - c. Ventilación mecánica invasiva(**no se intuba de entrada, a menos que tenga hipercarbía**)
 - d. Naricera flujo 0.2 ml/kg
 - e. Naricera flujo 2 ml/kg
- 135. Cáncer vs TBC, tenia baja de peso, hipocratismo digital ¿Cuál es el examen a realizar?
 - a. **TC con contraste**
 - b. Broncoscopía tb
- 136. Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo?
 - a. **Histerectomía con preservación de ovarios**
- 137. Pediátrico, 2 días de dolor abdominal, diarrea líquida 10-15 episodios/día, 3 máculas que blanquean a la presión en abdomen, hepatomegalia, hemograma con Eosinofilos en 0, Anemia, coprocultivo negativo.
 - a. **Salmonella tify**
 - b. Campylobacter
 - c. Salmonella enteritidis
 - d. Shigella
 - e. E. Coli entero hemorrágica
- 138. Si aumenta la velocidad de envejecimiento en la población que pasara en temas de salud publica:
 - a. Aumento de cobertura de adultos mayores en APS
 - b. **Aumento de personas con fragilidad**
 - c. Aumento en la variabilidad de morbilidad o mortalidad
- 139. Mujer con cefalea súbita e intensa + signos meníngeos esbozados, con antecedente de pansinusitis crónica y migraña, al control de signos vitales con PA 170/100 ¿Cual es la conducta inicial mas importante?
 - a. **TAC de cerebro**
 - b. Control de crisis hipertensiva
- 140. Niño o adolescente con conducta disruptiva + crisis de ausencia ¿Como estudiarlo?
 - a. **Electroencefalograma**
 - b. TAC

- c. RNM
- d. Psicometria
- 141. Femenina con atracones, luego salía a correr 5 hrs y consumía 200 kcal/día, intentaba vomitar pero no podía:
 - a. **Bulimia nerviosa**
 - b. **Anorexia**
 - c. Trastorno por atracones
- 142. Paciente pierde el trabajo hace 4 semanas, y hace 3 semanas inicia con los siguientes síntomas: subido de peso y tenía insomnio, pero después decía sin anhedonia - depresión o distimia?
 - a. **Trastorno adaptativo** porque no cumplía el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se
 - b. Trastorno depresivo mayor
- 143. Mujer que ha sido muy aprehensiva con los estudios y preocupada por su familia, pareja y relaciones amorosas, al punto de estar todo el tiempo estresada y con problemas digestivos, ella refiere sentirse así desde la pérdida de su abuelo (que murió hace 5 años), los padres refieren que ha sido así desde chica:
 - a. **Trastorno ansiedad generalizada**
 - b. **Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)**
- 144. Paciente encontrada en el baño, tenía carboxiHb de 12% tto de elección:
 - a. **O2 mascarilla**
 - b. Cámara hiperbarica
- 145. Era una clínica de ojo rojo, pero con temblor en las manos y baja de peso, al examen físico se observa retracción palpebral:
 - a. **TSH y T4 libre**
- 146. Paciente con apnea del sueño, tenía polisomnografía con 65 episodios por hora, hipertrofia de cornetes conducta:
 - a. **CPAP**
 - b. Cirugía de cornetes
- 147. Adulto mayor con temblor al escribir, un temblor esencial ¿Con que se trata?
 - a. **Propanolol**
- 148. Paciente con contractura de músculos masticatorios con úvula desplazada. rigidez de nuca esbozada, dolor cervical, gran exudado de amígdalas bilaterales:
 - a. Absceso retrofaringeo
 - b. Flegmon periamigdalina
 - c. **Absceso peritonsila**
 - d. Absceso retrotonsilar
- 149. Mujer joven, aborto hace 3 meses, tiene anemia, hace una TVP confirmada por eco doppler, estudio etiológico:
 - a. **SAF**
 - b. Estudio Lupus
 - c. Pedir antitrombina III
 - d. Estudio TVP??
- 150. Paciente con ERC, con TVP poplítea, cual es la mejor terapia anticoagulante:
 - a. **Heparina no fraccionada**
 - b. Enoxaparina
 - c. Dabigatran

- d. Rivaroxaban
 - e. Acenocumarol
151. Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses? Con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias,, y preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas?
- a. TEP
 - b. Fibrosis pulmonar
 - c. IC
 - d. **Cor pulmonale ???**
152. Paciente que tenía una insuficiencia cardiaca aguda, con tercer ruido y todo?
- ***NO RECUERDO ESTA PREGUNTA QUE ALGUIEN LA COMPLEMENTE*
- a. CORE Pulmonar del EPOC
 - b. ICD
153. Mujer cursando embarazo de 37 semanas, consulta por prurito palmo-plantar. En los exámenes destacan ácidos biliares de 110- 112, conducta:
- a. **Interrupción del embarazo**
 - b. Ácido ursoderxecolico
 - c. Antihistamínicos
154. Paciente con sd nefrotico y hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:
- a. **Lupus**
 - b. Amiloidosis
 - c. Mieloma múltiple
155. Test de esfuerzo alterado cual era el siguiente paso?:
- a. **Coronariografía**
156. Estudiante 4to año medicina, con miedo hablar en público y quedarse en blanco-
- a. **Fobia social**
157. ECG con supra st DII, DIII y aVF- medida inicial más adecuada:
- a. **Reperusión**
 - b. Doble antiagregación (PORQUE NO PODRÍA SER)
158. Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:
- a. **Ecocardiograma**
159. Paciente presenta bradicardia de hasta 35, Hipotensa, K 8, Cual es la primera medida
- a. **Gluconato de Ca → Una paciente con bradicardia y potasio como 7-8 (creo que esta había salido antes en algun EUNACOM)**
 - b. Diálisis de urgencia
 - c. MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE UN BLOQUEO AV SI EN EL MARCAPASO SE VA A MORIR, porque lo primero en toda hiperK y arritmia es estabilizar membrana con Gluconato Ca)
160. **Había un intestino irritable ?? - sii una señora con antecedente de SII, con cambio en patrón evacuatorio, sospechar neoplasia. Decía que tenía aumento de la severidad de los sintomas, y en explicito que no tenía baja de peso ni otros signos de alarma, yo puse una que decía hemograma y algo mas. Era Colono, es una bandera roja tener diarrea/cambio en deposiciones en AM**

→Colono → **NO SE ENTIENDA LA REDACCION DE ESTA PREGUNTA Y NO RECUERDO ALGUIEN QUE LA MEJORE**

161. Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:
- litiasis en vía biliar comun**
 - lesión vía biliar iatrogenica**
162. Paciente femenina, en su día 10 de ciclo menstrual, dolor abdominal súbito, con tumor anexial 7 cm, diagnóstico mas probable
- Torsión ovárica**
 - Endometrioma
 - Diverticulitis aguda
163. Paciente con vision tubular, y un signo de humo de chimenea en el ojo __. Visión derecho digital? e izq 20/20. Reflejo fotomotor alterno/RFM alterado creo . ¿Cuál es el diagnóstico? **ALGUIEN QUE MEJORE ESTA PREGUNTA A LAS ALTERNATIVAS: me parece que esta tenía glaucoma de ángulo abierto en las alternativas?**
164. Paciente mujer joven sodio bajo osmolaridad sanguínea baja, sodio urinario sobre 100, osmolaridad urinaria 520 (VN 50-1200), VEC normal
- SIADH**
 - Uso de diuréticos (creo que era esta, pues el SIADH debería tener osmolaridad urinaria alta, que alguien confirme pls)**
 - Insuficiencia suprarrenal
 - Hipotiroidismo
165. Paciente de 18 años con púrpura palpable (no trombocitopénico??) que no desaparece a la digitopresión:
- Purpura henocho schonlein**
166. Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:
- Suspender ACO y controlar en 3 meses** (yo puse esta porque pensé q estaba sangrando por la suspensión del ACO y por lo tanto no se podía interpretar el engrosamiento endometrial)
 - Legrado biopsico en pabellón
 - Biopsia aspirativa de forma ambulatoria. **(QUE TIPO DE BIOPSIAS APARECIAN/MEJORAR LAS ALTERNATIVAS)**
167. Señora asintomática en control, sin anemia ni leucopenia, pero con trombocitopenia:
- Repetir hemograma**
168. Niño con historia de malestar general y fiebre 37.5°C-37.9°C de una semana de evolución, manejado con ibuprofeno. Le aparecia rash eritematoso en mejillas y Extremidades:
- Eritema infeccioso**
 - RAM
 - KAWASAKI
169. Paciente 18 años con +7 días? faringe eritematosa, adenopatías, múltiples consultas por el cuadro, le dieron amoxicilina. Al examen físico persiste con adenopatías, tenía un exantema rosado??. Conducta:
- Solicitar Elisa VIH**

- b. **IGM anti cápside epstein barr (según yo era esta, es un cuadro clásico de MNI y lo primero a descartar sería VEB, luego VIH) (es epstein barr porque en síndrome retroviral el dx se hace con PCR no elisa)**
- 170. Cáncer ileo cecal algo **asii no recuerdo la pregunta** (no estaaa)
- 171. (178) Paciente de 78 años con antecedentes de HTA DM2 vértigo recurrente en tratamiento con Losartán Metformina y Cinarizina. Consulta por 3 meses de temblor en EESS y caídas frecuentes. Al examen físico temblor de reposo en EESS bilateral y simétrico, leve rigidez y marcha enlentecida. Sin focalidad, sin alteraciones en la sensibilidad, Minimental 30/30
 - a. Temblor esencial
 - b. Neuropatía DM
 - c. Hidrocefalia normotensiva
 - d. **Parkinsonismo por fármacos (cinarizina)**
 - e. Enfermedad de Parkinson
- 172. ¿Cual es el estudio de Hipercalcemia ?
 - a. **Calcemia y PTH**
- 173. Había un AM con alteraciones de memoria creo, con VCM > 100: B12 **(ALGUIEN RECUERDA ALGO DE ESTO)**
- 174. FORUNCULO QUE HACER
 - a. **ATB**
 - b. Drenar
- 175. Espirometría con VEF1/CVC 0,35% no mejoró post broncodilatador y el VEF1 50%
 - a. Fibrosis pulmonar
 - b. **Insuficiencia cardiaca derecha**

ECG:

1. TPSV tratar con adenosina
2. RN con Dx TPSV
3. SCACEST IAM INFERIOR revascularizar
4. Pediátrico con taquicardia QRS angosto tto con CVE sincrónica.

SOS Q TANTO SUBEN LOS PTJES? Aprox ?? Q les han dicho :o ?? Subirán 5% o no tanto ?

Pq subirian? Si es que eliminan preguntas y estandarizan